Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Caí

Rua São Lourenço, 1113 - Bairro: Centro - CEP: 95760000 - Fone: (51) 3635-1113 - Email: frsaoscai1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001998-14.2021.8.21.0068/RS

AUTOR: GISELE CRISTINE MULLER
RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Gisele Cristine Muller, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, em face de Bradesco Saúde S/A, também qualificado. Narrou que foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico, CID 10 M32.1 (FAN, anti-dna, serorites, nefrite classe 2, leucolinfopenia), motivo pelo qual iniciou tratamento com glicocorticoide em doses altas desde fevereiro de 2018 e teve resposta clínica parcial, persistindo doença cutânea, articular e renal em atividade. Contou que necessitou associar ao tratamento os fármacos hidroxicloroquina, azatioprina e metotrexato em doses máximas, sem sucesso também. Lhe foi prescrito o medicamento BELIMUMABE 600mg (Benlysta®) e, por ser cliente do réu (contrato entabulado em 21/03/2019, carência até 21/03/2021), o hospital em que estava sendo atendida solicitou ao plano de saúde o fornecimento do medicamento indicado pelo médico, o que foi negado sob o argumento de que "patologia não contemplada pela ANS para uso de med imunobiológica", motivo pelo qual requereu o fornecimento do remédio, inclusive em tutela de urgência. Discorreu sobre o direito que entende lhe assistir, bem como quanto aos danos morais experimentados, requerendo a procedência dos pedidos e a concessão da gratuidade de justiça.

Foi deferida a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência (ev. 03).

Citado (ev. 13), o réu contestou, arguindo a ausência de obrigação da cobertura eis que o medicamento Belimumabe 600mg não se encontra listado nas Diretrizes de Utilização da ANS, oportunidade em que se trata de risco excluído de cobertura, não havendo qualquer responsabilidade da seguradora ré, considerando que a apólice em questão foi contratada na vigência da Lei n.º 9.656/98. Disse que o fornecimento da medicação reclamada só seria de cobertura obrigatória pelas Operadoras/Seguradoras de Saúde se cumpridos os critérios estabelecidos por essa agência reguladora em sua Resolução Normativa, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo previsão de utilização – pela ANS – do belimumabe para a doença da qual padece a autora. Afirmou a inexistência de dano moral, ante a ausência de prática de ato ilícito. Desta forma, postulou pela improcedência dos pedidos (ev. 18).

Houve réplica (ev. 24).

As partes foram intimadas quanto à pretensão dilatória (ev. 6), tendo a parte ré se manifestado quanto a ausência de outras provas a serem produzidas (ev. 31) e a autora mantido-se inerte (ev. 32).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado do feito, forte no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, pois há elementos suficientes nos autos para solucionar a lide.

Não havendo questões preliminares a demandar enfrentamento, adentra-se, imediatamente, no exame do mérito da demanda.

No que tange à aplicação do CDC no caso em tela, já de início, esclareço que a incidência é subsidiária, aplicando-se no que a lei específica silenciar, na forma do art. 35-G da Lei dos Planos e seguros privados de assistência à saúde[1]. Ademais, a lei n. 9.961/2000 que criou a ANS, posterior a publicação da Lei 8.078/1990 (CDC) garante ainda, à sujeição ao princípio da cronologia, estabelecendo no art. 4º, inciso III que detém legitimidade para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.

Dito isso, não há nenhuma dúvida no tocante ao fato de que o contrato de seguro é bilateral, ensejando direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se *ad nutum* do liame obrigacional, sendo que resulta necessária a preservação do adequado equilíbrio entre as partes, pena de ocorrência de lesão a qualquer delas.

E o equilíbrio contratual deriva, à evidência, das próprias cláusulas contratuais, que retratam a existência do negócio jurídico efetivado em todos os seus aspectos, no que diz com a titulação de direitos e o suporte de encargos, ou seja, diz com a observância do pactuado em seus termos, pena de ocorrência de lesão a qualquer dos contratantes, e, por outro lado, quanto a necessária interpretação e integração contratual, merece observância o ensinamento de Maria Helena Diniz, consoante segue:

1. Interpretação e integração contratual

Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponto obscuro ou controvertido. A tarefa do intérprete do contrato encontrará uma série de dificuldades, pois além de analisar o texto contratual, deverá examinar a intenção comum dos contratantes. A atividade interpretativa do contrato é uma operação difícil, que requer saber e prudência, devendo o intérprete guiar-se pelo sentimento jurídico, que o impedirá de cair em interpretações alheias à vida. A interpretação contratual poderá ser declaratória, se tiver por único móvel a descoberta da intenção das partes interessadas no momento da realização do contrato, ou construtiva, se objetivar a reconstrução do ato negocial, possibilitando assim a produção de seus efeitos.

A interpretação situar-se-á na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

.....

A integração contratual vem a ser um processo lógico-sistemático que possibilitará preencher lacunas encontradas nos contratos, complementando-os por meio de normas supletivas, emitidas pelo poder competente.

Os autores italianos, baseados no Código Civil italiano, arts. 1.339 e 1.440, denominam tal processo de integrativo.

A interpretação contratual terá por escopo determinar o conteúdo contratual duvidoso, buscando seu verdadeiro sentido, eliminando ambiguidades, dúvidas ou contradições, resultantes do texto do contrato.

A integração contratual, por sua vez, pretenderá desvendar os efeitos do contrato, nas hipóteses em que apresentarem falhas ou lacunas, em decorrência de ausência de previsão ou conhecimento das partes contratantes ou de não correspondência do contrato a fatos ou valores não supridos pela via interpretativa. A integração contratual seria, portanto, um modo de aplicação jurídica feita pelo órgão judicante, mediante o recurso à lei, à analogia, aos costumes, aos princípios gerais de direito ou à equidade, criando norma supletiva, que completará, então, o contrato, que é uma norma jurídica individual. Logo, com a aplicabilidade dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, ter-se-á a colmatação da lacuna contratual, no caso sub judice. (Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, vol. I, p. 81/84).

Assim, considerada a lição doutrinária antes transcrita e presente a circunstância no sentido de que *como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas*, resulta a conclusão quanto ao fato de o contrato contemplar necessidade de observância das cláusulas contratuais em seus termos, a qual encontra-se na efetiva *intenção comum dos contratantes*.

Na causa em exame, no entanto, não há dúvida de que o contrato foi firmado sem que à demandante restasse possibilitada a discussão das cláusulas contratuais em seus termos, eis tratar-se de verdadeiro contrato de adesão, padronizado e previamente impresso, cabendo-lhe apenas aderir ao contrato, pena de não haver a contratação objetivada.

Ocorrida a contratação nos termos antes explicitados, portanto, resulta a ocorrência de situação fática a determinar a necessidade de ser emprestada interpretação mais favorável à requerente das cláusulas contratuais, nos exatos termos do disposto no artigo 47 do CDC, sendo que, por outro lado, não pode ser desconsiderada a própria finalidade do seguro-saúde, obviamente consubstanciada em que seja garantida a saúde do segurado em sua plenitude, nos exatos termos do objetivado pela Lei nº 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, de 03.06.98), a qual, por exemplo, no artigo 35-C (com a redação dada pela Lei n. 11.935/2009), veda a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação, e, em seu artigo 12, § 2º, determina:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ora, presente a determinação legal de fornecimento de cobertura em casos de emergência, bem assim considerado que o seguro-saúde tem por finalidade primeira garantir a saúde do segurado em todas as situações de patologia, resulta a conclusão sobre a indevida negativa de cobertura securitária, à ótica de incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie também por força da Súmula 469 do STJ (*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.*).

De interpretação dos dispositivos legais antes transcritos, portanto, dúvida não existe quanto ao fato de haver cobertura securitária para o tratamento objetivado pela demandante, com a utilização do fármaco prescrito pela médica assistente, notadamente quando há previsão inclusive para tratamento domiciliar, nos termos do disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.

Outrossim, a 4ª Turma do STJ, que, em ***overruling***, no REsp.n. 1.733.013/PR, sustenta que a opção do legislador, através das Leis n.9656/1998 e 9961/2000, foi de disciplinar uma lista e eventos em saúde que constituirão referência básica, sendo que a ANS, na condição de Agência Reguladora, o incrementará com a incorporação de novas tecnologias. Esse rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar o direito à saúde com preços acessíveis, contemplando camada mais ampla e vulnerável da população. No entanto, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde, é necessário encontrar meio termo analisando-se a possibilidade de cobertura pelos planos privados. *In verbis*:

> *PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.1.* ***A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde.*** *O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito,* ***por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde****. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o* ***rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde****. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4.* ***O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população.*** *Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que* ***é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas****. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6.* ***O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico****. A uníssona doutrina especializada alerta para a* ***necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar.*** *A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020) (grifei)*

Importante salientar que a Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País.

Especificamente no art. 4º, I e III, consta a disposição legal de que compete à ANS ***in verbis***:

> *I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;*
>
> ***III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades;*** *(grifei)*

Desse modo, restou legalmente estabelecido que é competência legal da ANS, dentre outras, a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde.

Em razão de tal legitimidade, destaco, por oportuno, que em 24/02/2021, a ANS aprovou nova Resolução Normativa (RN) n° 465/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definindo, então, a cobertura mínima a ser observada nos planos de saúde, a classificação dos procedimentos, bem como eventuais carências que devem ser observadas, atendendo, na integralidade, as disposições da Lei nº 9.656/98, dispondo sobre os novos exames e tratamentos que passam a fazer parte da lista obrigatória dos planos de saúde, guardadas as obrigações respectivas nos contratos de planos de atendimento ambulatorial, nos de internação hospitalar, os com obstetrícia e os com atendimento odontológicos, prevendo, inclusive, a taxatividade do rol, nesse sentido, **sic**:

> *Art. 2º Para fins de cobertura,* ***considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos,*** *podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (grifei)*

Nesse contexto, é essencial que o tratamento/medicamento conste como sendo de cobertura obrigatória nos termos das diretrizes normatizadas pela ANS (rol), ressaltando ser ilícita a cláusula contratual que disponha a respeito de exclusão do tratamento, quando claramente presente a cobertura no rol, por se tratar de cobertura mínima obrigatória, o que enseja a aplicação do disposto no artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, merece registro o fato de não haver controvérsia relativamente à necessidade do medicamento devido à condição de saúde da autora.

Com efeito, conforme se observa das prescrições médicas do Evento 1, LAUDO 14, o médico que assiste a autora recomendou a realização do tratamento com a utilização do fármaco "Belimumabe 600 mg (10 mg/kg)". Segundo informou o profissional, diante da evolução clínica da doença, a única opção terapêutica adequada ao caso da autora é o medicamento negado pela ré.

O medicamento indicado pelo médico que assiste a autora é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – , conforme consta no Evento 1, OUT21, e possui indicação, na sua descrição (*vide* documento do Evento 1, OUT22) para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico (LES) ativo, doença que acomete a autora, conforme demonstra o laudo médico e exames do Ev. 1, OUT5 e OUT16. Alega a parte ré, no entanto, que o medicamento não está contemplado nas diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -.

Dentre as diretrizes constantes no anexo II da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, encontra-se a diretriz de n.º 65, que trata de casos em que a cobertura pelas operados de plano de saúde para a Terapia Imunobiológica Endovenosa é obrigatória:

> *65. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA PARA TRATAMENTO DE ARTRITE REUMATÓIDE, ARTRITE PSORIÁSICA, DOENÇA DE CROHN E ESPONDILITE ANQUILOSANTE; TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA PARA TRATAMENTO DE ARTRITE REUMATÓIDE, ARTRITE PSORIÁSICA, DOENÇA DE CROHN E ESPONDILITE ANQUILOSANTE*
>
> ***1. Cobertura obrigatória quando preenchidos os seguintes critérios:***
>
> ***a. artrite reumatoide:*** *pacientes com índice de atividade da doença maior que 10 pelo CDAI (Índice Clínico de Atividade da Doença), maior que 20 pelo SDAI (Índice Simplificado de Atividade da Doença) ou maior que 3,2 pelo DAS 28 (Índice de Atividade da Doença - 28 articulações), refratários ao tratamento convencional por um período mínimo de três meses com pelo menos dois esquemas utilizando drogas modificadoras do curso da doença (DMCDs) de primeira linha, de forma sequencial ou combinada;*
>
> ***b. artrite psoriásica:*** *pacientes com comprometimento periférico, índice de atividade da doença maior que 3,2 pelo DAS 28 (Índice de Atividade da Doença - 28 articulações) ou igual ou maior que 5 pela EVA (Escala Visual Analógica) na presença de no mínimo três articulações dolorosas ou edemaciadas, refratários ao tratamento convencional por um período mínimo de seis meses com pelo menos duas drogas modificadoras do curso da doença (DMCDs) e, nos pacientes com comprometimento axial associado ao periférico, índice de atividade da doença igual ou maior do que 4 pelo BASDAI (Índice Bath de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante), refratários ao tratamento convencional por um período mínimo de três meses com doses plenas de pelo menos dois antiinflamatórios não hormonais (AINHs);*
>
> ***c. doença de Crohn:*** *pacientes com índice de atividade da doença igual ou maior a 220 pelo IADC (Índice de Atividade da Doença de Chron), refratários ao uso de drogas imunossupressoras ou imunomoduladoras por um período mínimo de três meses; ou com índice de atividade da doença maior que 3,2 pelo DAS 28 (Índice de Atividade da Doença - 28 articulações), nos casos de comprometimento articular periférico; ou com índice de atividade da doença igual ou maior do que 4 pelo BASDAI (Índice Bath de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante), nos casos com comprometimento axial;*
>
> ***d. espondilite anquilosante:*** *pacientes com índice de atividade da doença igual ou maior do que 4 pelo BASDAI (Índice Bath de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante) ou igual ou maior do que 4,5 pelo ASDAS (Escore de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante), refratários ao tratamento convencional por um período mínimo de três meses com doses plenas de pelo menos dois antiinflamatórios não hormonais (AINHs) e, nos pacientes com doença predominantemente 9 periférica com ausência de resposta à sufassalazina ou ao metotrexato, por período adicional de 3 meses.*
>
> ***e. Esclerose Múltipla****: Cobertura obrigatória do imunobiológico Natalizumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III: Grupo I a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-RR); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica com a utilização de glatirâmer e betainterferona anteriormente; f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses; g. Ser encaminhados a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax; h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3 e linfócitos acima de 1.000/mm3 ao hemograma. 69 Grupo II a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva (EM-PP) com surto; b. Incapacidade de adesão ao tratamento e impossibilidade de monitorização dos efeitos adversos; c. Intolerância ou hipersensibilidade ao medicamento; d. Diagnóstico de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP); e. Pacientes que apresentem maior risco de infecções oportunistas; f. Pacientes com câncer, exceto se carcinoma basocelular de pele. Grupo III a. Surgimento de efeitos adversos intoleráveis após considerar todas as medidas atenuantes; b. Falha terapêutica definida como dois ou mais surtos no período de 12 meses, de caráter moderado ou grave (com sequelas ou limitações significantes, pouco responsivas à pulsoterapia) ou evolução em 1 ponto na escala Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou progressão significativa de lesões em atividade da doença.*

Tal previsão está contida na atual RN 465/2021, anexo II, nos seguintes termos, ***sic:***

*65. **TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 65.1 ARTRITE REUMATÓIDE***

*1. **Cobertura obrigatória** para pacientes com persistência da atividade da doença, conforme um índice ICAD (índices compostos da atividade de doença), após falha ao tratamento com o uso de pelo menos dois esquemas terapêuticos com medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos (MMCDS), por, no mínimo, 3 meses cada um.*

*65.2 **ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ)***

*1. **Cobertura obrigatória q**uando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. Subtipos AIJ oligoarticular estendida, AIJ poliarticular, artrite relacionada a entesite, artrite psoriásica e artite indiferenciada: • cobertura obrigatória para pacientes com atividade da doença, refratários ao tratamento convencional por um período mínimo de 3 meses. b. Subtipo AIJ sistêmico: • cobertura obrigatória para pacientes com atividade da doença, refratários ao tratamento convencional por 7 a 14 dias.*

Desta forma, em que pesem as alegações da parte ré, ainda que o quadro clínico da autora não preencha todos os requisitos previstos na Diretriz de Utilização, visto que portadora de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – LES (CID 10: M32.1), a terapia imunobiológica endovenosa, está prevista como de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de modo que a negativa de cobertura se mostra abusiva.

Nesse sentido, seguem precedentes do egrégio STJ, em casos análogos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

*1. **Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento inserido no rol da ANS prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off-label") (AgInt no AREsp 1.713.784/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021).****

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ocorrência do dano moral, além do referente à existência de previsão contratual de cobertura para a doença que atingiu o consumidor, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das cláusulas contratuais.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1919623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021) (grifei)

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO **OFF LABEL**. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. **"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)"** (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/5/2020 - sem destaques no original*

Dessa forma, deve a ré fornecer toda cobertura necessária ao tratamento da autora, incluindo medicamentos e procedimentos ambulatoriais e hospitalares, além de custear as despesas referentes a todos os procedimentos que se fizerem necessários para salvaguardar sua saúde e integridade, e relevando ser destacado que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual, oportunidade em que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura do custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. **LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. TRATAMENTO. MEDICAMENTO BELIMUMABE**. **NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.** I. No caso concreto, a autora, é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.1), apresentando lesões de pele progressivas, necessitando realizar tratamento com a medicação

denominada Belimumabe, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano de saúde. II. Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. (…) (Apelação Cível, Nº 70078839859, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-09-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **DIAGNÓSTICO DE *LÚPUS* ERITEMATOSO SISTÊMICO. MEDICAMENTO BELIMUMAB (BENLYSTA). PRESCRIÇÃO DE USO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA.** 1. Os planos de *saúde* estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica ao aderente. Inteligência da Súmula 608 do STJ. 2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as partes prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos correlatos. 3. O *plano* de *saúde* não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082678244, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 25-09-2019).

E relativamente à escolha do tratamento a ser realizado ou o tipo de medicamento a ser utilizado pelo segurado, cabe ao médico fazer a indicação mais apropriada ao seu paciente e não ao plano de saúde, pois este não pode se recusar a custear medicamento prescrito pelo profissional da medicina, cabendo ao especialista definir o que é melhor para o paciente, merecendo ser destacado o constante no art. 21 do Código de Ética Médica, o qual está previsto que é direito do médico *"indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País"*.

Ainda, tem-se que a pretensão da autora encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde afastada a possibilidade ao plano de escolher o procedimento médico a ser adotado, cuidando-se de critério estritamente médico:

Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010).

Logo, inexistindo expressa exclusão do plano de saúde da autora para o tratamento da doença, tendo a médica receitado a substância BELIMUMABE (Benlysta), não há que se falar em negativa da ré em fornecê-lo à demandante, impondo-se a procedência do pedido para fins de confirmar a tutela de urgência concedida, objetivando o fornecimento do referido medicamento.

Com relação à indenização por danos morais, entendo que no caso dos autos merece guarida a pretensão da parte autora.

Salienta-se, a propósito, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o descumprimento contratual pela operadora do plano de saúde enseja reparação extrapatrimonial somente quando houver agravamento das condições de dor, abalo psicológico ou prejuízo à saúde do paciente, como se vê:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES. CONDUTA ABUSIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 2.DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Terceira Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato.
2. **De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.**
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1904024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o descumprimento contratual por

parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no REsp 1.653.581/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 12/09/2019).
2. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que a hipótese não ultrapassou o mero aborrecimento, consignando que, da recusa, não decorreu nenhum dano moral à parte. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1818224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

No que concerne ao tema em discussão, são também os arestos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a seguir:

AÇÃO ORDINÁRIA. *PLANO* DE *SAÚDE*. RADIOTERAPIA IMRT. NEGATIVA DE *COBERTURA*. DESCABIMENTO. *DANOS MORAIS*. CORRÊNCIA. CASO CONCRETO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. No caso concreto, a autora, por requisição médica, necessitou submeter-se à realização do tratamento de Radioterapia de Intensidade Modulada de Feixe (IMRT), cuja *cobertura* foi negada pela operadora do *plano* de *saúde*. II. Assim, o objeto do presente recurso diz respeito somente à *indenização* por *danos morais*, pedido não acatado na sentença. III. Quanto aos *danos morais*, embora a negativa de *cobertura* pelo *plano* de *saúde* possa caracterizá-los, a questão deve ser examinada caso a caso. Na hipótese dos autos, é cabível a *indenização* pretendida, uma vez que a situação narrada reflete o *dano* moral in re ipsa ou *dano* moral puro, tendo em vista que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são presumidos, atingindo a parte autora em momento de induvidoso abalo psicológico por conta da séria doença que a atingia e da necessidade do tratamento, o que confere o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Inclusive, foi necessário o ajuizamento da presente demanda para que fosse autorizado o tratamento, sendo deferida antecipação de tutela. IV. Redimensionamento da sucumbência, considerando o decaimento integral da ré em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083440826, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 15-04-2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C *INDENIZAÇÃO* POR *DANOS MORAIS*. *PLANO* DE *SAÚDE*. MEDICAMENTO. DOENÇA PULMONAR. *COBERTURA* DEVIDA. *DANOS MORAIS*. OCORRÊNCIA. 1. Os contratos de *planos* de *saúde* estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de *plano* de *saúde* não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. 2. Mostra-se abusiva a negativa da ré em autorizar a realização da terapia endovenosa com utilização do medicamento Rituximabe, uma vez que cabe ao médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a melhor opção para a realização do tratamento, bem como indicar os exames necessários à melhora da doença e qualidade de vida da paciente. 3. *Dano* moral. Caso concreto em que a negativa de *cobertura* extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a dor, a angústia e o abalo psicológico por que passou a parte demandante, considerando as peculiaridades dos autos. 4. Quantum indenizatório. Quantia que deve ser fixada em observância às particularidades do caso e com o objetivo de garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083461533, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. *PLANO* DE *SAÚDE*. NEGATIVA DE *COBERTURA* DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. DESCABIMENTO DA RECUSA. *DANO* MORAL. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora objetiva a condenação da ré ao ressarcimento do valor despendido com o procedimento cirúrgico para implante do anel-estromal (anel de ferrara), julgada parcialmente procedente na origem. Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ. Com efeito, trata-se de um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores, a teor do que preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da referida legislação. No caso em comento, a cirurgia de implante de anel intra-estromal (Anel de Ferrara), consta no Rol de *Cobertura* Obrigatória da Resolução Normativa n. 338/2013, de modo que considera-se abusiva a negativa da seguradora ré, uma vez que, através dos documentos acostados nos autos, resta incontroverso que a parte autora é portadora de ceratocone nos dois olhos, estágio equivalente a grau II (fls.21/26), de modo que mostra-se injustificável a negativa de *cobertura* por parte da demandada. A injusta recusa de *cobertura* de seguro *saúde* dá direito ao segurado ao ressarcimento dos *danos* extrapatrimoniais sofrido. Precedentes do e. STJ. A *indenização* por *dano* moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se pode esquecer que o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de *indenização*, em hipóteses símiles, fixo o valor da condenação à título de *danos morais* em R$10.000,00 (...). DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA

RÉ DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 70083152439, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-04-2020)

No presente feito, não se trata de mero descumprimento contratual, mas de desatendimento à obrigação assumida que gera profunda angustia e dor psíquica ao beneficiário do contrato por não obter o restabelecimento da saúde da forma mais adequada e eficaz.

No caso em exame, depreende-se pelos documentos carreados aos autos que a negativa da ré em fornecer o medicamento implicou em ofensa à integridade psíquica da parte autora, em razão do desnecessário e significativo sofrimento da demandante, tendo que ajuizar a presente demanda para obter a cobertura do tratamento necessário em sede de antecipação de tutela.

Assim, restou evidenciada a ilicitude da conduta adotada pela ré, em razão da evidente necessidade de início imediato do tratamento postulado, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado, com laudo médico declarando que a não utilização do medicamento prescrito aumenta o risco de infecções graves e, consequentemente, morte, bem como que a requerente **apresentou piora adicional clínica e laboratorial após a negativa em relação ao acesso ao medicamento imunobiológico** (ev. 1.14).

Por conseguinte, a prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão a parte demandante, mesmo que de ordem extrapatrimonial, atingindo a sua esfera físico-psíquica, fato que prescinde de culpa, restando inafastável o dever de ressarcir os danos morais causados, na forma do artigo 186 do Código Civil.

A responsabilidade no caso dos autos também é de ordem objetiva para reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário, atentando à boa-fé objetiva ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Com efeito, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de que a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido, não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso.

Dessa forma, para a fixação do *quantum* indenizatório deve ser levado em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Nesse sentido, considerando a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica e o dúplice caráter da reparação, arbitro a indenização a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora, o qual deve ser corrigido pelo IGP-M a partir do arbitramento (publicação desta sentença) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual.

Impõe-se, pois, a procedência da ação.

Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência e julgo **PROCEDENTE** o pedido, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao efeito de **determinar** que a ré a forneça a cobertura securitária pretendida pela autora, consubstanciada no fornecimento do medicamento BELIMUMABE (Benlysta), na forma prescrita pelo médico assistente da demandante (Evento 1 - LAUDO14), bem como **condenar** a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora, corrigido pelo IGP-M a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Sucumbente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme art. 82, §2º do CPC/15. Quanto aos honorários advocatícios, estabeleço em 10% do valor da condenação, ao patrono da parte adversa, considerando o trabalho desenvolvido pelos profissionais e a complexidade do feito, nos termos do art. 85, §2º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Havendo recurso de apelação interposto, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 1.010, §1º do CPC.

Na hipótese, do §1º do art. 1.009 do CPC, deverá a parte apelante ser intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme §2º do referido dispositivo legal.

Após, ao eg. Tribunal, com as diligências de estilo.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **REGIS PEDROSA BARROS, Juiz de Direito**, em 29/11/2021, às 18:11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10013158601v23** e o código CRC **9cf9417c**.

1. Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990. ↩